

■ DATOS SINTÉTICOS - SOLO PARA PRUEBAS - NO ES PACIENTE REAL ■

Este documento fue generado automáticamente para el desarrollo del clinical-extractor de SICA. No contiene PHI ni representa una paciente real. Cualquier semejanza con un caso clínico real es coincidencia.

HISTORIA CLÍNICA OBSTÉTRICA (manuscrito digitalizado)

Centro Materno-Infantil (sintético) — Consultorio de Obstetricia

Nota: documento digitalizado a partir de manuscrito; calidad de OCR variable.

FILIACIÓN

Nombre:	PACIENTE SINTÉTICA - NO REAL
Edad:	26 años
Estado civil:	Conviviente
Ocupación:	Asistente administrativa
Fecha de elaboración:	18/02/2026

ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS

Fórmula obstétrica: G1 PO. Primigesta. Menarquia: 1Z años. Régimen catamenial regular previ0. Sin antecedentes patológic0s pers0na1es ni familiares relevantes.

GESTACIÓN ACTUAL

FUM:	20/09/2025
FPP:	27/06/2026
EG actual (por FUM):	22 semanas
Controles prenatales:	3 al momento
Centro de control:	Mismo centro

Paciente refiere movimient0s fetales presentes desde semana 19. No refiere sangrado, ni pérdida de líquido, ni contracciones. Sin signos de alarma al momento de la consulta.

LABORATORIOS (último control: 10/02/2026)

Analito	Resultado	Unidad	Observación
Hemoglobina	11.6	g/dL	Dentro de rango
TSH	1.8	mUI/L	Dentro de rango
Glucosa basal	86	mg/dL	Norma1
HIV (ELISA)	N0 reactivo	—	Negativo
Sífilis (RPR)	No reactivo	—	Negativa

ECOGRAFÍA DE LAS 20 SEMANAS (10/02/2026)

Fet0 único, vivo, en presentación cefálica al momento del estudio. Biometría acorde a edad gestacional. Peso fetal estimado 380 g. Placenta anterior, grado 0. ILA dentr0 de rango n0rmal. Anatomía fetal sin anomalías estructurales observables.

EXAMEN FÍSICO ACTUAL

PA 108/68 mmHg. FC 80 lpm. T° 36.5°C. Peso 60.5 kg. Talla 1.60 m. AU 21 cm. LCF 146 lpm. Edema MMII (-/-).

PLAN

1. Continuar suplementación con ácido fólico y calcio según pauta. 2. Iniciar sulfato ferroso profiláctico 60 mg de hierro elemental VO c/24 h. 3. Control prenatal en 4 semanas. 4. Educación sobre signos de alarma obstétricos. 5. Tamizaje de DG entre semanas 24-28.